

Reparación de prolapso vaginal con malla / injerto biológico

Información para el paciente · Reforzar la reparación de un prolapso con material de soporte adicional **WARWIKI**

Algunas reparaciones de prolapso que se hacen por la vagina se refuerzan con un **injerto** — material de soporte adicional que se coloca donde su propio tejido está débil. El material puede ser un **injerto biológico** o, en situaciones seleccionadas, malla. Esta hoja explica las opciones con honestidad, incluido el historial de seguridad de la malla vaginal, para que pueda tomar una decisión informada con su cirujano.

Acerca de este procedimiento

A través de una incisión vaginal, se repara la pared debilitada y se coloca un injerto para dar más fuerza y reducir la posibilidad de que el prolapso vuelva. Los materiales incluyen:

- **Injerto biológico** — de tejido humano o animal donado; el cuerpo lo absorbe con el tiempo mientras su propio tejido sana.
- **Malla sintética** — un material permanente, usado **de forma selectiva** y con asesoramiento cuidadoso.

Contexto importante de seguridad

La **malla sintética** transvaginal para el prolapso fue objeto de **advertencias de la FDA** y ya no se vende para este uso en los EE. UU. por riesgos como la exposición de la malla y el dolor. Hoy en día, el prolapso se repara con mayor frecuencia con **su propio tejido (nativo)** o un injerto biológico; la malla abdominal (como en la sacrocolpopexia) sigue siendo una opción aparte y bien respaldada. Su cirujano le explicará exactamente qué material está planeado y por qué.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Prolapso

Cuando los órganos pélvicos descienden y causan un bulto o presión.

Injerto

Material de soporte adicional que se coloca durante la reparación.

Injerto biológico

Material a base de tejido que el cuerpo absorbe con el tiempo.

Malla sintética

Un material permanente; restringido para el uso en prolapso transvaginal.

Reparación con tejido nativo

Una reparación que usa solo su propio tejido, sin injerto.

Exposición de la malla

Cuando una parte de la malla se vuelve visible o se palpa; puede causar dolor o flujo.

¿DEBO PREOCUPARME POR LA MALLA? Es una pregunta justa. Los problemas que llevaron a las advertencias fueron específicamente con la **malla sintética transvaginal para el prolapso**. Las reparaciones con tejido nativo, los injertos biológicos y la malla abdominal tienen perfiles de seguridad distintos y bien estudiados. Lo clave es entender exactamente qué planea su cirujano y por qué — pregunte.

Preguntas para hacerle a su cirujano

- ¿**Qué material** va a usar — tejido nativo, injerto biológico o malla sintética — y por qué en mi caso?
- ¿Cuáles son los **riesgos específicos**, incluida la exposición de la malla o el dolor durante las relaciones sexuales?
- ¿Cuáles son mis **alternativas** (reparación con tejido nativo, sacrocolpopexia, un pesario)?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el prolapso **vuelva** con cada opción?

Cómo prepararse

- Siga sus **instrucciones de anestesia** (ayuno, suspenda los anticoagulantes según le indiquen).
- No fume; organice quién lo lleve a casa y ayuda en el hogar.
- Planee tareas livianas y reposo pélvico durante varias semanas.

Después de la cirugía

- Es normal tener manchado o flujo durante unas semanas.
- **Evite levantar cosas pesadas, hacer esfuerzos y las relaciones sexuales durante unas 6 semanas.**
- Mantenga las heces blandas; regrese a su actividad de forma gradual.

Llame a su equipo de atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos, o sangrado abundante
- **No puede orinar**, o dolor que empeora
- Más adelante: **dolor durante las relaciones sexuales**, flujo inusual, o que su pareja sienta algo (posible exposición de la malla)

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un injerto da soporte adicional a la reparación de un prolapso vaginal — los injertos biológicos se absorben con el tiempo; la malla sintética es permanente y se usa de forma selectiva.
2. La malla transvaginal para el prolapso tuvo advertencias de la FDA; la reparación con tejido nativo y los injertos biológicos son comunes, y la malla abdominal es una opción aparte.
3. Pregunte exactamente qué material está planeado y por qué. Informe si más adelante tiene dolor durante las relaciones sexuales o flujo inusual.